

Eine autistische Arbeitnehmerin / einen autistischen Arbeitnehmer in Ihrem Arbeitsmedizin-Team

Für Arbeitsmedizin-Pflegekräfte und Arbeitsplatz-Gesundheitspersonal — einen autistischen Erwachsenen in Beschäftigung unterstützen.

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit eines Erwachsenen in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Arbeitsplätze — Großraum, laut, voller Unterbrechung und ungeschriebener Regeln — treiben Masking und **autistisches Burnout**, das von gewöhnlichem beruflichem Stress und Depression zu unterscheiden ist. Als Arbeitsmedizin-Pflegekraft sind Sie gut platziert, es zu erkennen, von Leistungsproblemen zu trennen und die reasonable Anpassungen zu vermitteln, die eine fähige Arbeitnehmerin/einen fähigen Arbeitnehmer gesund und in Beschäftigung halten.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Erschöpft, verliert Kompetenzen, erholt sich nach der Arbeit nicht	Autistisches Burnout — von beruflichem Burnout und Depression zu unterscheiden
In der Praxis „gut“, bricht tagelang danach zusammen	Starkes Masking ; ein 15-Minuten-Besuch zeigt selten die Kosten
Meldet Schmerz, Symptome oder Nebenwirkungen erst, wenn schwer	Interozeptions -Unterschiede
Konflikte, die mit Großraum, Meetings, Schicht-Arbeitsplätzen zusammenhängen	Ein Umwelt-Pass-Problem, kein Kompetenzproblem
Will alles schriftlich; meidet Anrufe	Eingekanalige Kommunikation senkt die Last

Versuchen Sie dies

- **Bieten Sie das AASPIRE AHAT** vorab und **schriftlich-zuerst**-Optionen; erlauben Sie eine Begleitperson.
- **Erkennen Sie autistisches Burnout** und verwechseln Sie es nicht mit Depression oder „schlechter Resilienz“.
- **Vermitteln Sie reasonable Anpassungen**: ruhiger Raum, schriftliche Anweisungen, weniger Meetings, asynchrone Kommunikation, definierte Erwartungen.
- **Medikamente niedrig beginnen und langsam titrieren** — atypische sensorische/emotionale Reaktionen sind häufig.
- **Dokumentieren Sie wirksame Anpassungen**, damit sie beim nächsten Mal automatisch sind.

Vermeiden Sie dies

- Eine ruhige, maskierte Visite über Selbstbericht und Anamnese stellen.
- Burnout als Depression behandeln und einen „Rückkehr-zur-vollen-Last“-Plan drängen.
- „Nicht klagen“ mit „nicht leiden“ gleichsetzen.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Untersuchen Sie auf **Suizidalität** — Burnout ist damit verknüpft. Behandeln Sie begleitende **ADHD (AuDHD), Angst, Depression, Schlaf- und GI-Zustände**. Wo Burnout schwer ist, validieren Sie gestaffelte Rückkehr, reduzierte Stunden oder einen Rollenwechsel als Erholung, nicht als Schwäche.

Wenn der/die Arbeitnehmende eine Frau ist

Spät-diagnostizierte Frauen masken am stärksten; nehmen Sie ein lebenslanges Muster von Unterschied und Überlastung ernst, auch bei einem „leistungsstarken“ Äußeren.

Über diesen Leitfaden

*KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teile 3.4 & 4) und das **Monotropismus**-Dossier. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an die einzelne Person an.*

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Mantzalas et al. (2022); Kelly Mahler (2024); AASPIRE AHAT. Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.